ACADÉMIE
DE RECHERCHE ET
D'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

Bleu

Collez votre étiquette d'identification en respectant le cadre.

CONCOURS D'ENTRÉE ET D'ACCÈS EN SCIENCES MÉDICALES ET EN SCIENCES DENTAIRES

25 AOUT 2023

APRÈS-MIDI

LES QUESTIONNAIRES DOIVENT RESTER AGRAFÉS.

RUE ROYALE 180 / 1000 BRUXELLES / BELGIQUE
T +32 2 225 45 11 / F +32 2 225 45 05
WWW.ARES-AC.BE

CAPACITÉS TRANSVERSALES A

ÉVALUATION DES CAPACITÉS DE RAISONNEMENT, D'ANALYSE, D'INTÉGRATION, DE SYNTHÈSE, D'ARGUMENTATION, DE CRITIQUE ET DE CONCEPTUALISATION

Lisez attentivement le texte suivant.
C'est sur ce texte que portent les questions n°1 et n°2

Les mécanismes du sommeil obéissent à un système de double régulation, l'une rythmique, qui régule périodiquement l'apparition du sommeil toutes les 24 heures (on parle de rythme circadien), l'autre homéostatique qui dépend de substances hypnogènes dont l'accumulation est proportionnelle à la durée de la veille préalable.

Après avoir cru dans les années 1980 qu'on allait trouver « l'hormone du sommeil », force est de constater que les candidats sont nombreux, notamment parmi les substances également impliquées dans les processus inflammatoires ou infectieux. L'adénosine, une substance endogène semble jouer un rôle prépondérant nettement mieux connu. Les taux d'adénosine augmentent avec la durée de l'éveil, finissant par entraîner une somnolence puis l'endormissement. Elle agit comme un neuromédiateur inhibiteur des structures assurant l'éveil. Après l'endormissement, et au fur et à mesure du décours du sommeil, la concentration d'adénosine diminue, en même temps que le besoin de sommeil. La caféine qui permet de rester éveillé agit en s'opposant à l'action de l'adénosine par ses propriétés antagonistes des récepteurs adénosinergiques A1.

Pour s'endormir une fois les systèmes d'éveil inhibés, il faut que les systèmes de sommeil se mettent en route. En fait, un seul est connu à ce jour. Situé dans l'aire préoptique de l'hypothalamus antérieur ventrolatéral, il contient des neurones sécrétant de l'acide gamma-aminobutyrique et de la galanine qui inhibent les réseaux de l'éveil.

On s'est interrogé sur l'importance de notre environnement pour réguler nos rythmes de sommeil. Pendant longtemps, on a cru que le synchroniseur social était prédominant. Effectivement, le fait de vivre dans un milieu entraînant du point de vue des rythmes est important. […] A contrario, la perte de tout repère comme on peut le voir chez les gens âgés […] est un facteur de désynchronisation et donc de troubles du sommeil. Un autre synchroniseur est fondamental, il s'agit de la lumière du jour.

Source : Selon le texte modifié de Sylvie Royant-Parola, Psychiatre, sur
https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/medecine-tout-savoir-sommeil-845/page/3/

Question 1. Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ?

Le texte affirme que la régulation du sommeil…

A. dépend à la fois de l'accumulation de certaines substances et du rythme circadien.
B. est conditionnée essentiellement par l'accumulation de certaines substances endogènes.
C. est conditionnée essentiellement par la durée de la luminosité naturelle du soleil.
D. est conditionnée essentiellement par un rythme périodique de 24 heures.

Question 2. Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ?

Le texte affirme que pour s'endormir, il faut…

A. que l'hypothalamus atteigne l'aire préoptique.
B. que certains acides atteignent l'hypothalamus.
C. que la galanine inhibe l'effet de la caféine.
D. que certains neurones de l'hypothalamus sécrètent certaines substances.

Question 3. Deux joueurs, X et Y, doivent se partager une somme de 100 €. Il revient à X de faire une proposition de partage et il revient à Y de l'accepter ou non. Si Y accepte la proposition faite par X, X et Y reçoivent les sommes respectives proposées par X ; si Y refuse, ils ne reçoivent rien (0 €). X et Y sont parfaitement rationnels et égoïstes : ils essaient simplement de maximiser leur gain. De plus, chacun sait que l'autre est aussi rationnel et égoïste que lui-même.

Les sommes proposées étant nécessairement des nombres entiers, laquelle des propositions de partage suivantes devrait faire X pour s'assurer de maximiser son gain ?

A. 100 € pour X et 0 € pour Y.
B. 99 € pour X et 1 € pour Y.
C. 50 € pour X et 50 € pour Y.
D. 1 € pour X et 99 € pour Y.

Question 4. Imaginons un pays P et un citoyen X de ce pays P. X dit : « Tous les citoyens de P sont des menteurs ».

Laquelle des propositions suivantes concernant ce qu'énonce X est correcte ?

A. X ne se contredit pas nécessairement. En effet, il se peut que ce que dit X soit vrai et qu'il y ait des citoyens de P qui soient menteurs.
B. X se contredit nécessairement. En effet, si ce qu'il dit est vrai, ce qu'il dit est faux ; et si ce qu'il dit est faux, ce qu'il dit est vrai.
C. X se contredit nécessairement. En effet, ce que dit X est faux puisqu'il est un citoyen de P, et dès lors ce qu'il dit est vrai.
D. X ne se contredit pas nécessairement. En effet, il se peut que ce que dit X soit faux et qu'il y ait au moins un citoyen de P qui ne soit pas menteur.

Lisez attentivement le texte suivant.
C'est sur ce texte que portent les questions n°5 et n°6

La génétique des populations est une branche de la biologie qui étudie la diversité génétique et l'évolution des populations d'organismes vivants. Elle permet de comprendre comment les variations génétiques se propagent dans une population et comment elles peuvent influencer l'adaptation et la survie des individus. Les études en génétique des populations ont également des implications importantes en médecine, en écologie et en agriculture.

Les variations génétiques se produisent naturellement dans les populations en raison de mutations aléatoires, de la recombinaison génétique lors de la reproduction sexuée et de la migration des individus entre les populations. La fréquence des allèles (les différentes formes d'un même gène) dans une population peut varier en fonction de divers facteurs, tels que la sélection naturelle, la dérive génétique et les mutations. La sélection naturelle favorise les allèles qui confèrent un avantage adaptatif à un individu dans son environnement, tandis que la dérive génétique peut entraîner une perte d'allèles dans une petite population en raison du hasard.

La théorie de l'évolution de Darwin explique comment les variations génétiques se propagent dans les populations au fil du temps et comment de nouvelles espèces peuvent émerger à partir de populations ancestrales communes. La génétique des populations a permis de préciser cette théorie en identifiant les mécanismes génétiques qui sous-tendent l'évolution et en quantifiant les taux de mutation, de migration et de sélection dans les populations.

Les études en génétique des populations ont des implications importantes en médecine, en particulier dans le domaine de la génétique médicale. Les variations génétiques peuvent être à l'origine de maladies héréditaires et l'identification de ces variations peut aider à la prévention, au diagnostic et au traitement de ces maladies. De même, la génétique des populations est utile en écologie pour comprendre comment les populations animales et végétales se comportent dans leur environnement et comment les activités humaines peuvent les affecter.

En agriculture, la génétique des populations est utilisée pour sélectionner les variétés les plus résistantes aux maladies et aux conditions environnementales défavorables. Elle est également utilisée pour préserver la diversité génétique des cultures et des espèces animales menacées d'extinction.
En somme, la génétique des populations est une discipline clef de la biologie qui nous permet de comprendre la diversité et l'évolution des populations d'organismes vivants. Elle a des implications importantes en médecine, en écologie et en agriculture, et son importance ne cesse de croître à mesure que nous en apprenons davantage sur la complexité de la vie sur Terre.

Question 5. Quelle est, selon les informations du texte, l'utilité de la génétique des populations en médecine ?

A. Elle permet de préserver la diversité génétique des cultures et des espèces animales menacées d'extinction.
B. Elle permet de comprendre comment les populations animales et végétales se comportent dans leur environnement.
C. Elle permet de sélectionner les variétés les plus résistantes aux maladies et aux conditions environnementales défavorables.
D. Elle permet de prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies héréditaires.

Question 6. À partir des informations données dans le texte, comment la dérive génétique peut- elle affecter une petite population ?

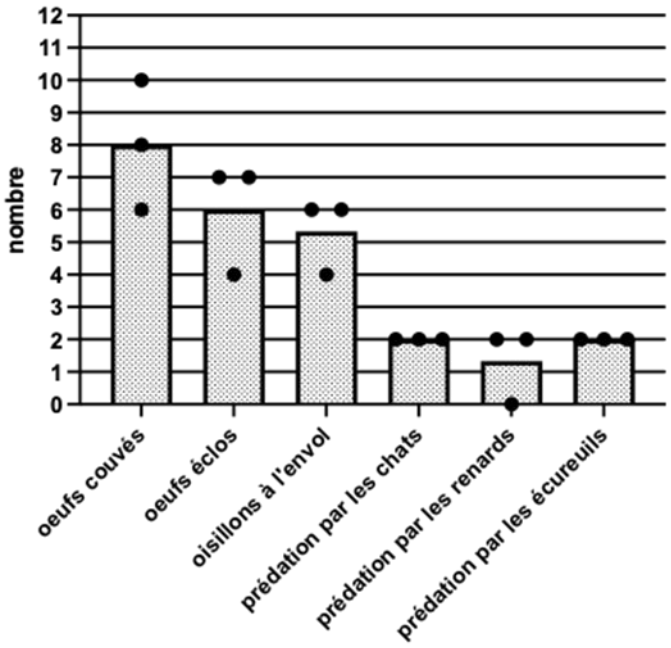
A. Elle peut réduire la migration des individus entre les populations.
B. Elle peut entraîner une perte d'allèles en raison du hasard.
C. Elle peut favoriser les allèles qui confèrent un avantage adaptatif à un individu dans son environnement.
D. Elle peut augmenter la fréquence des mutations dans la population.

Question 7. On relève l'évolution d'une concentration d'une protéine P toutes les 24 heures : 10,0 mg / litre le jour 1 ; 10,2 mg / litre le jour 2 ; 10,5 mg/ litre le jour 3 et 10,9 mg / litre le jour 4. L'imprécision de la mesure implique que les valeurs observées peuvent s'écarter de 0,5 mg / litre des valeurs réelles, tant par excès que par défaut.

Laquelle de ces affirmations est vraie ?

A. La concentration réelle n'a pas nécessairement augmenté entre le jour 1 et le jour 4.
B. La concentration mesurée sera de 11,4 mg / litre le jour 5.
C. La concentration réelle sera supérieure à 10,9 mg / litre le jour 5.
D. La concentration réelle a augmenté exponentiellement durant les 4 premiers jours.

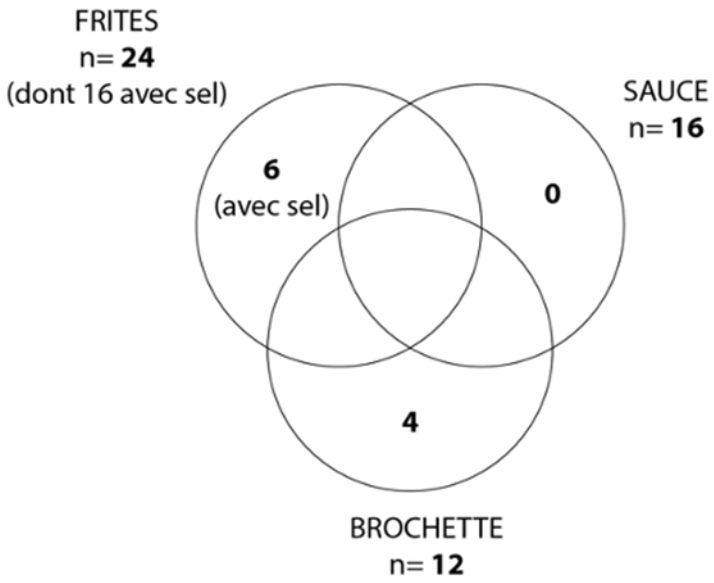
Question 8. Le graphique ci-dessous montre les chiffres relatifs aux nichées de mésanges à huppe striée dans 3 nichoirs de la région de Tapioca. Les colonnes montrent les moyennes des nombres recensés à la fin de la saison et les points (boules noires) donnent les valeurs individuelles pour chacun des trois nichoirs.
Ne sont considérés comme « couvés » que les œufs qui ont été couvés plus d'une semaine.
Les proies typiques des prédateurs mentionnés sont les suivantes : les chats attrapent et tuent les oisillons, parfois même à l'intérieur du nichoir ; par contre, les renards n'attrapent que les oisillons après leur envol ; enfin, les écureuils ne mangent que les œufs pondus le jour-même.



Laquelle des 4 affirmations suivantes peut être déduite de ces données pour les trois nichoirs observés?

A. S'il n'y avait pas d'écureuils, les chats mangeraient plus d'oisillons.
B. Les mésanges à huppe striée pondent en moyenne moins de 10 œufs par nichée.
C. Les écureuils et les chats prélèvent le même pourcentage de leurs proies typiques.
D. Au moins 40% des œufs pondus n'ont pas éclos et donné naissance à des oisillons.

Question 9. Le diagramme ci-dessous peut être utile pour illustrer les commandes d'un groupe d'amis qui sont à la friterie.

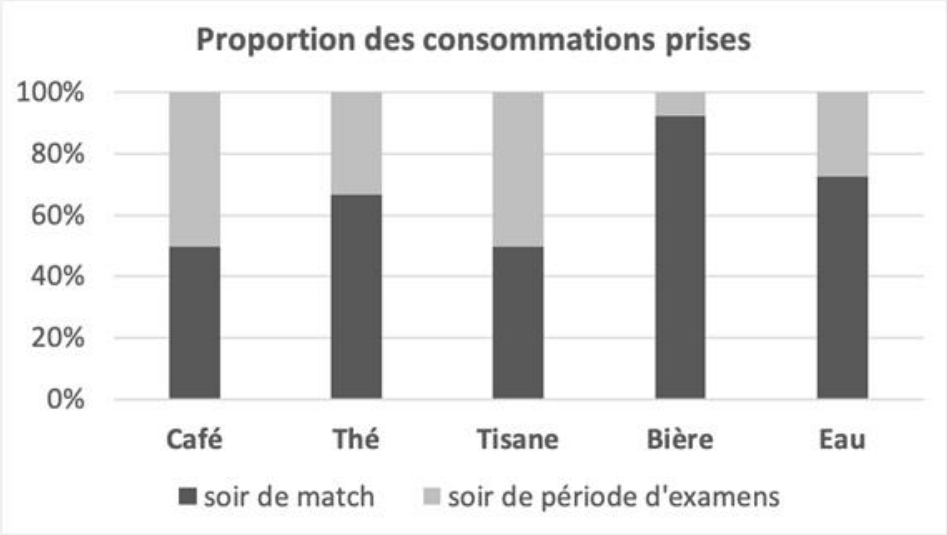


24 personnes ont commandé des frites (dont 16 avec sel et 8 sans sel).
12 personnes ont commandé des brochettes.
16 personnes ont commandé de la sauce.
Personne n'a commandé plus qu'un élément de chaque type (frites, brochette ou sauce).
Personne n'a pris de sauce sans prendre une brochette ou des frites. Quatre personnes ont pris des brochettes sans frites et sans sauce. Au total six personnes ont pris des frites sans brochette ni sauce, mais toutes avec du sel. Les personnes qui ont pris des frites sans sel ont toutes pris au moins de la sauce.

Indiquez laquelle des propositions suivantes est fausse d'après les données.

A. 5 personnes au maximum peuvent prendre des frites avec du sel, sans sauce avec une brochette.
B. Tous ceux qui mangent des frites sans sel mangent aussi des brochettes.
C. Si 7 personnes qui ont pris des frites avec du sel ont aussi pris de la sauce, on peut dire que 3 personnes ont pris des frites avec du sel, sans sauce avec une brochette.
D. Il est possible que parmi les mangeurs de brochettes, il n'y en ait aucun qui ait pris des frites et de la sauce.

Question 10. Le graphe ci-dessous montre les proportions des différentes consommations qui ont été prises au Café des sports un soir de match par rapport à un soir de la période d'examens.



Le tableau donne la proportion de buveurs de chaque type de boisson pour le soir de match et pour le soir de période d'examens. Chaque client consomme 2 boissons du même type par soirée.

Proportions des buveurs des différents types de boisson

	soir de match	soir de période d'examens
Café	20%	40%
Thé	20%	20%
Tisane	10%	20%
Bière	30%	5%
Eau	20%	15%

Laquelle des propositions suivantes peut être déduite des données ci-dessus ?

A. Il y a deux fois plus de clients au Café des sports le soir de match que le soir de période d'examens.
B. Il y a proportionnellement moins de buveurs de thé un soir de période d'examens.
C. Un client qui boit de la tisane un soir de période d'examens a tendance à boire de la bière un soir de match.
D. Il y a autant de buveurs d'eau que de buveurs de bière qui ont fréquenté le Café des sports les soirs concernés.

CAPACITÉS TRANSVERSALES B

ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ À COMMUNIQUER EN PERCEVANT LA DIMENSION ÉTHIQUE

ET EN FAISANT PREUVE D'EMPATHIE, DE COMPASSION, D'ÉQUITÉ ET DE RESPECT

1. Veuillez lire attentivement le texte ci-dessous.
2. Répondez ensuite aux 5 questions suivantes (questions 1 à 5).

F. vient de finir son doctorat de recherche en faculté de médecine et elle termine son contrat dans un mois. Le projet sur lequel était financée sa recherche incluait une autre chercheuse, H., elle aussi biologiste. Ensemble, elles avaient œuvré à la réalisation de tests sur animaux en vue d'élaborer un possible traitement pour une maladie rare. Elles ont ainsi collationné une base de données importante et abouti à une formule qui s'avère prometteuse pour stabiliser les patient·e·s atteint·e·s de cette maladie. Le projet est maintenant entré dans sa phase clinique, pour réaliser un ensemble de tests sur des hommes et femmes volontaires. La méthode pour élaborer le traitement est innovante et potentiellement révolutionnaire dans le secteur. Les chercheuses espèrent pouvoir déposer un brevet qui pourrait possiblement intéresser très vite les grandes entreprises pharmaceutiques.

F. a travaillé d'arrache-pied pendant les trois dernières années, au détriment de sa vie privée. Son petit ami l'a quittée. Il ne supportait plus qu'elle passe tout son temps au laboratoire. Lorsqu'elle s'épandait sur ses relations compliquées avec sa collègue H., il lui reprochait de toujours parler de son travail et de ne jamais être là pour lui. Il lui disait ne pas comprendre ce qui pouvait tant la préoccuper, plus que de mesure, car ce n'était après tout qu'un travail. Il lui reprochait d'être trop impliquée émotionnellement. Elle ressort épuisée de sa rupture et de sa fin de thèse. Son médecin a souhaité la mettre en arrêt la semaine dernière, mais elle a refusé.

Elle n'a pas eu la chance de son homologue, H., qui, elle, a été engagée après sa thèse. Elle se demande si c'est vraiment la voie pour elle et si elle ne devrait pas sortir du réseau universitaire qui ne l'aide pas à trouver son équilibre personnel. Toutefois, F. décide de continuer à introduire des nouvelles demandes de financement auprès de différents bailleurs de fonds afin de pouvoir poursuivre ses recherches. Elle est ainsi confrontée à l'urgence de renforcer son curriculum vitae en augmentant le nombre de ses publications dans des revues scientifiques, afin d'accroître ses chances d'être engagée.

En travaillant sur une synthèse de la littérature pour une future publication scientifique, elle découvre que sa collègue a publié une partie de leurs résultats en ne la mentionnant pas dans les auteurs de la publication, ce qui aurait permis de reconnaître sa part de travail !

Elle prend un rendez-vous avec leur chef de service, qui a cosigné l'article avec sa collègue H. Celui-ci ne souhaite pas intervenir. Il lui propose de laisser tomber et de se focaliser sur le plus important à savoir l'obtention d'un nouveau financement. F., fâchée, lui reproche de ne pas prendre ses responsabilités. Il n'entend pas s'épuiser dans les suivis de ce litige. Étant aussi le doyen de la faculté de médecine, il a d'autres problèmes plus urgents à résoudre. Elle sort en claquant la porte et en lui reprochant son manque d'intégrité.

Elle se met à pleurer dans le couloir. Ses collègues, techniciens du laboratoire, interloqués par sa tristesse, lui demandent de raconter la raison de celle-ci. Ce faisant, ils lui témoignent qu'ils sont désolés pour elle, mais qu'elle a été aveugle. Elle ne s'est pas rendu compte que H. et lui ont eu une liaison les deux premières années du projet. Cela s'était terminé très froidement il y a 6 mois.

Question 1. Désespérée par l'injustice de cette publication où elle n'a pas été mentionnée à titre de coauteur, elle raconte son histoire à son amie L.

Parmi les attitudes possibles de L., laquelle est la plus adéquate ?

A. L. constate que son amie ne voit pas l'essentiel et qu'elle accorde trop d'importance à des objectifs professionnels. Aussi, elle lui conseille de consulter un professionnel de la santé pour soigner sa dépression et réguler ses émotions.

B. L. prend le temps d'écouter son amie sur ce qu'elle vit et ressent ; elle l'aide à exprimer ce qui est important pour elle et à identifier ce qui pourrait l'aider à avancer. Elle évite cependant de personnellement prendre position.

C. L. confronte son amie et l'invite à faire valoir ses droits en matière de publication avec l'aide des juristes du service de transfert de technologie de l'université. Une clarification efficace est certainement la meilleure manière de témoigner du respect à F.

D. L. a déjà vécu ce que F. lui raconte, ce qui fait d'elle la personne la plus à même de l'aider, pense-t-elle. Elle lui fait part de son expérience de ce type de situation, car la connaissant bien, elle ressent que ce qu'elle a pu elle-même trouver comme solution conviendra à F. aussi.

Question 2. Le chef de service convoque F. pour une nouvelle réunion afin de ne pas en rester aux derniers échanges.

Parmi les propositions suivantes, laquelle décrit le comportement le plus adéquat ?

A. Il prend le temps de faire ressortir les non-dits, de s'ouvrir à ce que F. est en train de vivre et de prendre en considération les difficultés qu'elle rencontre actuellement. Ce faisant, un certain rapprochement s'installe.

B. Il lui rappelle qu'il reste son supérieur et que dans ce cadre, la manière dont F. a clôturé la discussion n'est pas professionnelle. C'est cependant pour lui témoigner son soutien, précise-t-il, qu'il a souhaité la revoir. Il ne voudrait pas que ses derniers comportements la discréditent auprès d'autres membres de l'université.

C. Il lui exprime son malaise dans cette situation et lui demande de comprendre qu'il se retrouve dans une situation très délicate avec sa collègue H. ; par respect et empathie à l'égard de H., il se doit de rester discret.

D. Il lui conseille de ralentir ses activités à l'université et de se reposer pour prendre du recul sur ses ambitions de carrière et accepter ce qui lui arrive. Il réalise, par son expérience de chef de service, que c'est le conseil le plus avisé qu'il aurait voulu recevoir s'il avait été dans la position de F..

Question 3. F. a pris la décision de consulter une psychiatre pour bénéficier d'un accompagnement médical pendant cette période de vie bousculée.

Parmi les propositions suivantes, laquelle est la mieux adaptée à la situation ?

A. La psychiatre écoute les inquiétudes de F. et investigue avec elle son expérience et ses ressentis pour approfondir son diagnostic et décider avec F. si la prise en charge médicamenteuse sera opportune voire nécessaire.
B. La psychiatre lui recommande de quitter le monde universitaire. Son expérience personnelle lui a en effet montré que c'est un système qui peut malmener les gens sans aucune forme de retour sur l'investissement passé.
C. La psychiatre lui dit qu'elle a une grande expérience de ce type d'épuisement professionnel et lui indique ce qu'elle pense être le mieux pour elle, tout en lui prescrivant un antidépresseur pour l'aider.
D. La psychiatre considère qu'elle est, explique-t-elle à F., la seule juge en mesure de prendre les bonnes décisions pour elle, car dans son état de détresse, F. ne sera pas en mesure de prendre du recul sur sa vie professionnelle et personnelle.

Question 4. F. parvient à prendre du recul par rapport à ce qui lui est arrivé ; persuadée que de toute manière l'injustice de la publication est irrémédiable, et considérant que la réussite du projet est une preuve de sa qualité, elle décide de positiver.

Parmi les démarches envisageables ci-dessous, laquelle est la meilleure ?

A. Laisser entendre que le laboratoire se livre à des pratiques douteuses en matière de bien-être animal.
B. Retourner voir le chef de service et souligner franchement, mais calmement, les erreurs de management que ce dernier a commises.
C. Entreprendre de salir la réputation de H. au sein de l'équipe en propageant des allusions sur ses relations avec les hommes, en particulier ceux qui ont du pouvoir.
D. Retourner voir le chef de service mais cette fois avec une intention de détendre la relation, sans plus revenir à la publication.

Question 5. F. Décide de s'adresser par écrit au chef de service, ce qui, pense-t-elle, lui permettra de mieux gérer ses émotions et de faire valoir efficacement sa déconvenue et sa tristesse à la découverte de l'article ne mentionnant pas son nom en qualité d'auteur.

Parmi les quatre phrases suivantes qui pourraient figurer dans la lettre, laquelle est la plus acceptable ?

A. « J'aimerais beaucoup pouvoir éviter de devoir en référer à une instance d'intégrité scientifique ».
B. « Soyez assuré de mon profond respect pour la vie privée d'autrui, vie privée qui, vous en conviendrez, ne peut interférer avec le travail scientifique ».
C. « Je suis convaincue que cette liste d'auteurs incomplète relève d'une erreur matérielle ou d'un malentendu. Accepteriez-vous d'envoyer une demande de correction à l'éditeur ? ».
D. « Peut-être pourrions-nous en discuter de manière détendue, par exemple autour d'une bonne table, un de ces prochains jours ? ».

1. Veuillez lire attentivement le texte ci-dessous.
2. Répondez ensuite aux 5 questions suivantes (questions 6 à 10).

Madame D. est éducatrice depuis une vingtaine d'années dans un établissement d'enseignement secondaire. Récemment, la direction a amendé son règlement d'ordre intérieur afin de promouvoir une politique de tolérance zéro à l'égard du harcèlement scolaire. Celui-ci a effectivement augmenté de manière significative au cours des dernières années. Les membres du personnel et les élèves ont été particulièrement choqué·e·s par la tentative de suicide d'une jeune élève, W., qui subissait des faits de harcèlement depuis plusieurs mois. Le règlement précise notamment que tout soupçon de harcèlement doit être signalé à la direction, les sanctions pouvant aller jusqu'à un renvoi définitif de l'établissement.

En passant devant les toilettes, Madame D. aperçoit deux élèves de 5ème, S., une élève qui jouit d'une excellente réputation dans l'établissement, et L., une autre élève malheureusement bien connue de l'équipe éducative. L. est en effet une adolescente très mal dans sa peau, qui a déjà été sanctionnée à plusieurs reprises pour avoir fumé du cannabis dans l'enceinte de l'école et pour des propos injurieux tenus envers une autre élève. Les parents de L. sont séparés. L'adolescente vit chez sa maman qui traverse actuellement un épisode dépressif sévère et a beaucoup de difficultés à s'occuper de ses deux jeunes frères.

En dehors de S., L. a peu de copains et de copines au sein de l'école. Ce matin, S. avait accompagné L. aux toilettes car celle-ci était dans "tous ses états". A force d'insister, L. a fini par lui confier, en pleurs, que c'est très difficile à la maison car elle doit s'occuper du ménage, des repas, et des devoirs de ses jeunes frères, ce qui lui laisse peu de temps pour les sorties ou le travail scolaire. Sa seule échappatoire, ce sont ces « joints » qui l'apaisent transitoirement. L. reçoit quotidiennement des messages injurieux et connotés sexuellement de son ex-petit ami, M., qui, contre son gré, la suit souvent jusqu'à son domicile.

Lundi dernier, Madame D. a surpris M. en train d'utiliser son smartphone en salle d'étude, ce qui est interdit. Madame D., le trouvant particulièrement agité et sur la défensive, l'a pris à part pour en discuter avec lui. Il a fini par lui expliquer qu'il n'arrive pas à accepter sa rupture avec L., ce qui l'amène parfois "à déraper". En explorant la situation avec M., il ne fait aucun doute pour Madame D. que le comportement de M. à l'égard de L. est un comportement de harcèlement.

Madame D. termine cette semaine dans un état de grande fatigue. Elle apprécie énormément son travail et son contact avec les jeunes, mais la multiplication des situations difficiles comme celle de L. et de M. ou encore le souvenir du suicide qui a endeuillé l'école ont un impact délétère sur son moral ; elle ne peut s'empêcher de ramener ces préoccupations à la maison.

Question 6. Face à la détresse de L., S. souhaite se montrer amicale pour tenter de soulager le poids de ses soucis.

Laquelle des attitudes suivantes rencontrerait le mieux cet objectif ? L'amie (S.)…

A. communique à L. qu'elle lui semble porter une situation fort difficile sur ses seules épaules, qu'elle sera certes toujours là pour l'écouter, mais que les professionnels du centre PMS (centre psycho-médico-social) pourraient peut-être lui apporter une aide qui dépasse ses propres compétences.

B. réconforte L. en lui disant que la situation de sa maman est sûrement temporaire et que dès qu'elle ira mieux les choses rentreront dans l'ordre. Pour lui changer les idées, elle lui offre un cinéma.

C. est réellement inquiète de la consommation de L. et tient à la mettre en garde sur les dangers de la consommation abusive de cannabis. Elle tente gentiment de lui faire comprendre que ce n'est pas en fumant qu'elle se sentira mieux.

D. encourage L. à aller au centre psycho-médico-social (PMS) de l'école pour en discuter avec un·e professionnel·le. Elle a même préparé toutes les coordonnées qu'elle a trouvées sur le site de l'école. Elle la prend par l'épaule et lui dit « Allez, vas-y, je te montre le chemin ».

Question 7. Madame D., qui a perçu la souffrance de M., souhaite tenter de l'aider à surmonter la situation.

Laquelle des attitudes suivantes rencontrerait le mieux cette intention ? L'éducatrice (Madame D.)…

A. exprime à M. son inquiétude pour L. mais aussi pour lui. Elle ne lui mentionne pas les conséquences et lui explique qu'il se sentirait mieux en présentant ses excuses à L.

B. tente d'aider M. à bien comprendre la gravité de son comportement en lui rappelant le suicide de la jeune W. Elle espère ainsi réveiller son sens des responsabilités et, de cette manière, éviter de gros ennuis tant à M. qu'à L.

C. explique à M. qu'elle devra référer la situation à la direction, puis elle aide M. à s'exprimer sur ce qui a pu l'amener à devenir si violent envers L. Elle pense que M. doit aussi beaucoup souffrir.

D. explique à M. que, selon le règlement, elle devrait faire une note à la direction qui pourrait amener à un renvoi. Elle lui propose de fermer les yeux pour cette fois.

Question 8. Madame D. est épuisée et réalise qu'elle a eu beaucoup de mal à rester à l'écoute des élèves, ces derniers temps. L'écoute, pour elle, est pourtant une valeur importante. Elle culpabilise d'éprouver, à l'encontre de certain·e·s élèves, énormément de ressentiment.

Face à ce constat, quel est le comportement le plus adéquat pour elle ?

A. Elle envoie un message à sa direction pour demander une entrevue lundi ou mardi. Elle va prendre le week-end pour réfléchir à des groupes de paroles qu'elle pourrait proposer aux élèves de façon à créer un espace de soutien par les pairs. Il est en effet temps de trouver des solutions.

B. Elle décide de voir son médecin traitant lundi matin pour discuter de l'utilité d'un congé maladie de deux semaines. Elle se culpabilise cependant pour S. et L. qui auraient bien besoin de sa présence les prochains jours. Toutefois, elle est consciente qu'elle doit prioriser et prendre soin d'elle pour rester efficace.

C. Elle sait que, dans son métier, l'épuisement émotionnel est récurrent. Bien que ce soit la première fois qu'elle ressent des émotions si négatives à l'égard des élèves, elle pense que l'épuisement est passager. Elle peut accepter cet état et d'être moins à l'écoute.

D. Elle sait qu'il est nécessaire de considérer chaque jour séparément. Elle va tenter de profiter de son week-end pleinement en favorisant des activités qui vont la divertir de façon à ne pas penser à son travail. Lundi est un autre jour et l'anticipation négative ne ferait que gâcher ses temps de loisirs.

Question 9. Madame D. trouve que la coupe est pleine : la consommation de drogue est une limite infranchissable ; le harcèlement aussi. Il faut qu'un évènement se produise pour débloquer la situation. Après en avoir discuté avec son compagnon, qui est également dans l'enseignement, elle se décide : maintenant, elle va agir concrètement.

Parmi les 4 propositions ci-dessous, laquelle est la meilleure ? Madame D. décide de…

A. convoquer L. et M. ensemble afin de voir avec eux s'ils ne pourraient pas se réconcilier. Elle partagera avec eux son propre mal-être, qui pourrait, en cas de leur réconciliation, diminuer beaucoup.

B. dénoncer la toxicomanie de L. auprès de la police. Cela lui permettra de se désintoxiquer de façon sûre et de casser le cercle vicieux qui caractérise cette situation compliquée.

C. proposer à M de le rencontrer avec d'autres collègues enseignants et lui expliquer l'inadéquation et les conséquences possibles de son comportement.

D. laisser à des collègues plus jeunes l'initiative : le poste de préfète va bientôt s'ouvrir (à la rentrée scolaire prochaine) et madame D. postulera. Elle pourra mieux traiter ces situations si elle n'est plus en contact direct avec les problèmes des élèves, tout en assurant que ses collaborateurs s'en occupent.

Question 10. Madame D, qui est littéralement malade de cette situation consulte son médecin généraliste.

Parmi les 4 propositions ci-dessous, concernant la réaction possible du médecin, laquelle est la meilleure ?

A. Après l'avoir écoutée, le médecin propose à Madame D. de questionner avec elle les possibilités envisageables. « Qu'estimez-vous meilleur pour votre santé physique et psychologique : prendre du repos ? Vous adonner à une activité sportive ? Prendre des séances de relaxation ?... Ou encore voir un psychologue ? ».

B. Le médecin écoute Madame D.. Très vite, il se fait son idée : rien de grave dans tout ça. Il amène Madame D. à convenir avec lui que l'ambiance dans les écoles se dégrade de plus en plus. Tout en saisissant son carnet, il lui dit « Soufflez un peu, ça va rapidement aller beaucoup mieux. Je vous prescris deux semaines de repos ».

C. Convaincu que Madame D., qu'il considère comme une battante, ne peut trouver son bien-être que dans l'action, il lui recommande de s'investir à fond dans la situation complexe qu'elle vient de découvrir. Il commente « Que feraient les élèves sans vous ? ». Il lui prescrit néanmoins des calmants pour l'aider à surmonter sa petite baisse de régime passagère.

D. Le médecin conseille à Madame D. de changer de fonctions : « Vous prenez de l'âge et les élèves sont de plus en plus difficiles à éduquer. En plus, vous êtes une personne très dévouée ; trop, sans doute. Pour votre bien, vous devez maintenant penser à changer d'occupation professionnelle. On n'a qu'une vie et ce métier vous détruit à petit feu ».

1. Veuillez lire attentivement le texte ci-dessous.
2. Répondez ensuite aux 5 questions suivantes (questions 11 à 15).

Le médecin généraliste, confronté aux problèmes de l'obésité aura une attitude différente selon la demande du patient, son aptitude au changement et sa motivation. Lorsque le patient n'est pas motivé pour perdre du poids, le rôle du médecin est d'éviter les complications et d'évaluer le risque lié à l'obésité et de mettre en place un travail sur la motivation. Lorsque le sujet obèse est prêt à modifier ses habitudes ou son comportement alimentaire, le traitement doit être adapté au patient. Une prise en charge inadéquate peut, non seulement se solder par un échec mais parfois aggraver l'obésité.
Le traitement de l'obésité vise 4 objectifs : la prévention de la prise de poids, la stabilisation du poids, le traitement des maladies associées et enfin la perte de poids.

Le traitement doit être réaliste dans ses buts comme dans ses moyens. Une perte de poids modérée (5–10 %) est souvent suffisante pour atteindre ces objectifs. Le traitement diététique et l'augmentation de l'activité physique constituent la pierre angulaire de la prise en charge.

Le résultat à long terme est le problème majeur des régimes. La perte de poids initiale dépend principalement de l'importance du déficit énergétique, alors que la stabilisation du poids est influencée par l'adhésion du sujet à un régime à faible densité calorique et surtout à l'augmentation de l'activité physique.

Améliorer l'image et l'estime de soi est également un objectif essentiel. Une psychothérapie est souvent nécessaire lorsque l'obésité trouve ses racines dans la sphère psychologique.
Les médicaments de l'obésité sont utiles pour des patients sélectionnés avec soin, en complément de l'approche diététique et comportementale, sous contrôle médical strict.

Question 11. Vous avez, vous-même, un copain en surpoids dont la santé vous inquiète ; quelle serait la meilleure entrée en matière pour aborder avec lui cette question ?

A. « Je n'ai jamais osé t'en parler, mais maintenant je me dis qu'il faut faire quelque chose : ton poids, ça vient de problèmes psychologiques ? Tu peux tout me dire, tu sais ».
B. « Je suis inquiet·ète pour ta santé, si tu veux nous pourrions commencer une petite activité sportive ensemble ; ça nous ferait du bien ».
C. « Il faut absolument que je te le dise, même si c'est délicat. Tu es vraiment trop gros, tu sais, je suis inquiet·ète pour toi ».
D. « Tiens au fond, je me demande : pour trouver des vêtements, tu fais appel à des sites ou des boutiques spécialisées dans les grandes tailles ? J'imagine que ça ne doit pas être évident… ».

Question 12. Un médecin généraliste se trouve en consultation devant un nouveau patient adolescent de 16 ans, à l'évidence, très obèse.

Parmi les 4 propositions ci-dessous, quelle est la meilleure question pour entamer cette première rencontre avec lui ?

A. « Ne vous en faites pas : on trouve toujours une solution pour l'obésité ».
B. « Cela ne doit pas être facile pour vous tous les jours ? Comment cela se passe-t-il en classe avec vos camarades ? ».
C. « Que puis-je faire pour vous ? ».
D. « Il y a combien d'années que vous souffrez de surpoids ? ».

Question 13. Un médecin généraliste découvre que son patient de 30 ans, obèse, qu'il suit comme toute la famille depuis de nombreuses années, développe à présent un diabète. Le diabète est une maladie complexe, souvent favorisée par l'obésité, et qui peut entraîner des complications graves. Le médecin craint que le patient et sa famille en viennent à perdre confiance en lui s'il ne fait rien de nouveau.

Parmi les 4 amorces de dialogue avec le patient présentées ci-dessous, laquelle est la plus adéquate ?

A. « Étant donné que vous ne parvenez pas à gérer suffisamment votre alimentation, vous risquez fort de développer toutes les complications du diabète ».
B. « Malheureusement, malgré le traitement, les choses se compliquent et je vais devoir vous envoyer chez un spécialiste du diabète ; nous continuerons ensuite à nous revoir régulièrement, notamment pour votre surpoids ».
C. « Le traitement de votre obésité ne semble pas fonctionner suffisamment, malgré vos efforts que j'apprécie. On va en rediscuter, se voir plus souvent et réussir ensemble à vaincre votre surpoids ».
D. « Votre taux de sucre est devenu trop élevé. Ne pouvez-vous pas faire un effort supplémentaire au niveau du sport ? Vous êtes bon au foot. Augmentez donc les heures de foot avec vos amis ».

Question 14. Un médecin généraliste soupçonne que, si le suivi depuis plus d'un an pour obésité franche chez son patient de 18 ans n'évolue pas positivement, c'est parce qu'en fait, celui-ci ne suit pas les recommandations prescrites au niveau régime et activités sportives.

Parmi les 4 messages ci-dessous que le médecin pourrait adresser au patient, lequel est le plus adéquat ?

A. « J'aimerais impliquer vos amis pour vous convaincre de mieux suivre votre régime. Qui parmi vos amis pourrait vous aider ? ».
B. « Il me semble que vous ne suivez pas le régime alimentaire prescrit, ce qui explique pourquoi nous ne progressons pas vraiment ».
C. « Expliquez-moi ce qui fait que, selon vous, nous ne progressons pas vraiment pour le traitement de votre obésité ? ».
D. « Vous savez qu'avec votre surpoids des complications vous guettent. Acceptez-vous que j'en parle à vos parents ? ».

Question 15. Un médecin généraliste remarque que, malgré des consultations fréquentes depuis un an, l'obésité pathologique augmente chez son patient âgé de 10 ans, qui, en plus, paraît se désintéresser franchement de son problème. Il faut d'urgence travailler à prévenir des complications pour la santé de cet enfant.

Parmi les 4 phrases ci-dessous que le médecin pourrait adresser à l'enfant, laquelle est la plus adéquate ?

A. « On ne va pas se décourager. Nous allons à nous deux gagner cette bataille pour ton bien mais il faut qu'on ait un résultat dans les deux mois. D'accord ? ».
B. « Que proposes-tu toi-même pour gérer au plus vite ta prise de poids trop importante ? ».
C. « On n'a plus de temps à perdre ; je vais devoir demander à tes parents de vérifier que tu suis bien un régime alimentaire strict et que tu fais du sport régulièrement pour préserver ta santé ».
D. « Si le mois prochain on ne voit pas une diminution du poids je devrai t'envoyer chez un spécialiste ou peut-être envisager une hospitalisation ».

Question 16. La situation de stress hydrique que connaît la planète pourrait rapidement avoir des conséquences catastrophiques. Les Nations Unies (ONU) ont d'ailleurs tout récemment prévenu que le monde doit se préparer en urgence à une crise de l'eau douce. L'assemblée générale des Nations Unies reconnaît l'accès à l'eau potable et à l'assainissement des eaux comme un droit humain fondamental depuis 2010 : concrètement, chaque être humain devrait pouvoir s'approvisionner en eau à moins de 1 km de son lieu de vie. Pourtant, un quart de la population mondiale n'a pas accès à l'eau potable. De plus, presque la moitié des humains ne disposent pas de toilettes ou d'autres systèmes d'assainissement des eaux usées. Ainsi, bon nombre d'individus défèquent en plein air et ne peuvent se laver les mains, ce qui les expose à un risque élevé d'épidémies.

Le Professeur R. veut faire réfléchir ses élèves (âgés de 15 à 16 ans) sur cette situation. Après les avoir informés, il lance un débat général, où il fait apparaître la question de savoir jusqu'à quel point on peut accepter qu'une personne ou une population soit privée d'accès à l'eau potable. Quatre étudiants prennent successivement la parole à la fin du débat.

Laquelle de ces conclusions est la plus légitime ?

A. R. souligne que la situation de stress hydrique ne libère pas de l'obligation morale de rechercher les moyens propres à mettre l'eau potable à la disposition de tous les êtres humains.

B. G. pense que la limitation d'accès à l'eau potable n'est tolérable que si la personne ou la population concernées ne sont pas en mesure d'assumer les conséquences financières de l'installation du matériel qui permettrait un approvisionnement satisfaisant.

C. B. estime que la limitation d'accès à l'eau potable est malheureusement inévitable si les ressources en eau potable sont limitées du fait de causes naturelles (géographiques, climatiques, …) dans le milieu de vie des individus concernés.

D. L. note que rendre l'eau potable accessible dans un espace où elle fait défaut ne doit pas impacter les droits économiques et sociaux des personnes et populations ne rencontrant pas ce problème.

Question 17. Dans les pays où un dispositif légal rend possible le suicide assisté (aide apportée à une personne qui veut se donner la mort), quelle doit être la ligne de conduite du médecin dans ses échanges avec un patient qu'il sait en phase terminale d'une affection léthale à brève échéance ?

A. Si, du fait de son histoire personnelle, le médecin ressent une gêne ou une crainte à l'idée de devoir aborder ce sujet avec le patient, il est préférable qu'il fasse en sorte d'éviter le sujet à l'occasion des consultations en changeant de sujet de conversation lorsqu'il sent que le patient pourrait en parler. Un faux-pas communicationnel pourrait avoir des conséquences très fâcheuses, dans cette situation très délicate.

B. Le médecin doit informer de façon loyale, claire et complète son patient si celui-ci évoque la perspective de se donner la mort et rester à l'écoute de ses attentes.

C. Le médecin n'a pas à se mêler de ces questions très personnelles, qui ne regardent que le patient lui-même, voire (à condition que celui-ci le souhaite) son entourage familial et/ou amical. Le mot « suicide » montre bien qu'il s'agit d'une décision de la personne par rapport à elle-même, et donc qu'elle est la seule à assumer sa décision.

D. Il n'y a pas de réponse universelle à cette question, qui ne relève que des opinions philosophiques et de la morale personnelle du médecin.

Question 18. Confronté à un patient atteint d'une grave affection incurable et léthale à brève échéance, quelle est la bonne attitude pour le professionnel de santé ?

A. Le professionnel de santé doit veiller à protéger le patient de la vérité sur son état afin de ne pas aggraver sa situation en y introduisant inutilement une dose additionnelle d'angoisse très délétère pour son bien-être.
B. Le professionnel de santé doit prioritairement veiller à sauvegarder la dignité du patient.
C. Le professionnel de santé doit impérativement se borner à imposer un traitement contre la douleur.
D. Le professionnel de santé doit, si la loi du pays le permet, proposer l'euthanasie au patient si celui-ci n'en parle pas.

Question 19. Un moniteur de ski en charge d'un groupe d'adolescents (7 garçons et 1 fille) se rend compte qu'un des apprentis skieurs qui lui ont été confiés prend trop de risques sur les pistes afin de se faire remarquer, pense-t-il, de la seule skieuse du groupe.

Quelle la bonne manière d'agir, pour le moniteur ?

A. Afin de couper court à ce dangereux manège, à la première imprudence, il interpelle l'élève sur le champ et lui signifie, en haussant le ton, qu'il prend des risques inconsidérés et qu'il ne pourra plus le tolérer.
B. Le moniteur entame discrètement un dialogue avec l'élève afin de calmer le jeu en lui indiquant qu'il y a plus important dans la vie : « Ta copine J. est bien mignonne et très gentille, je te comprends, mais il y a plus important dans la vie, par exemple se préserver d'un accident grave, qui pourrait te faire oublier les filles pour toujours ».
C. Le moniteur décide de choisir des pistes moins dangereuses où le risque d'accident est évidemment réduit.
D. Il décide de scinder le groupe en deux en mettant la jeune skieuse dans un autre groupe que l'élève.

Question 20. Un patron se rend compte qu'un de ses employés est fort stressé. Il suspecte que la raison est à trouver dans des problèmes que, dit-on, l'employé rencontre dans sa vie privée. Comme par ailleurs cet employé s'acharne à tenter de briller aux yeux du patron, celui-ci estime qu'il faut l'aider à mieux concilier vie professionnelle et vie privée.

Quelle est, pour le patron, la meilleure manière d'agir ?

A. Il tente de convaincre l'employé qu'il faut, au travail, oublier la vie privée afin de résister au stress.
B. Il suggère à l'employé de calmer le jeu au travail en prenant plus de recul par rapport à ses missions.
C. Il réorganise l'équipe en transférant une partie du travail qui incombait à l'employé à un autre qui est célibataire et semble résistant.
D. Il demande à l'employé quel est le problème domestique et tente de le résoudre avec lui.

Question 21. La préparation du concours d'entrée aux études d'ingénieur est rude. Pourtant, ce passage est une obligation. Quinze jours avant l'épreuve, vous apprenez qu'un de vos amis, étudiant de votre classe du secondaire, rencontre des difficultés pratiques importantes (problèmes financiers des parents, pas de connexion Internet,…). L'année passée, vous l'aviez déjà suspecté en faisant avec lui un travail en histoire sur la formation de l'Union européenne.

Parmi les 4 possibilités suivantes, laquelle est éthiquement acceptable ?

A. Vous suggérez à votre ami de se renseigner sur le service d'aide sociale de sa commune, dont c'est la mission d'aider les citoyens en difficulté personnelle.
B. Par respect, il vaut mieux ne pas réagir, afin que votre ami ne ressente pas de honte par rapport à sa situation sociale. Cette situation est avant tout une affaire personnelle. La discrétion s'impose.
C. Vous expliquez avec beaucoup d'empathie à votre ami que dans de telles circonstances, il ferait mieux de renoncer à devenir ingénieur. Il vaut mieux entreprendre, dans la vie, des combats qu'on est réellement en mesure de gagner.
D. Vous proposez à votre ami de lui permettre un accès à Internet chez vous puisque votre famille dispose de trois ordinateurs fonctionnels, et d'accéder à la bibliothèque de votre père.

Question 22. Lors du cours d'éducation physique à l'école secondaire, P. constate qu'un de ses condisciples, F., qui est son ami, présente de nombreux hématomes et il lui demande ce qu'il lui est arrivé. F. confie à P. que, lorsqu'il désobéit, ses parents lui « donnent une bonne correction » afin qu'il comprenne qu'il a mal agi. Il lui demande de garder le secret car il craint de subir encore plus de violences si ses parents apprennent qu'il s'est confié à P.

Quelle doit être l'attitude de P. ?

A. Il décide d'en parler à la professeure titulaire de la classe.
B. Il décide de rencontrer les parents de F. pour leur dire que ce qu'ils font est honteux.
C. Il demande à son père de dénoncer les parents de F. auprès du juge de la jeunesse.
D. Il conseille à F. de prendre contact avec le centre PMS (centre psycho-médico-social) de l'école pour relater les faits dont il est victime.

Question 23. Un homme âgé de 80 ans et fumeur de longue date consulte pour une toux persistante. Lors des visites chez la pneumologue, le patient ne pose aucune question et semble absent. Il est toujours accompagné de ses deux filles, et maintenant que des analyses poussées vont être réalisées, celles-ci ont expliqué discrètement à l'équipe soignante que leur père est très fragile psychologiquement et qu'il est préférable que les informations sur sa santé ne lui soient pas communiquées directement, surtout si elles sont mauvaises.

Les examens révèlent que le patient est atteint d'un cancer du poumon incurable avec des lésions secondaires au cerveau.

Comment la pneumologue devrait-elle communiquer ces résultats ?

A. Elle devrait prendre contact avec le médecin traitant du patient afin de décider en concertation avec lui comment informer au mieux le patient.
B. Elle devrait informer discrètement, par téléphone, les filles du patient, qui décideront elles-mêmes de l'attitude à adopter à l'égard de leur père.
C. Elle devrait donner toutes les informations au médecin traitant, afin qu'il puisse lui-même communiquer avec le patient.
D. Elle devrait fixer un rendez-vous au patient dans quelques semaines pour l'informer du résultat des examens. Entretemps, elle réfléchira à la meilleure manière de communiquer.

Question 24. Vous avez oublié de vous rendre à un examen écrit planifié à l'horaire. En fait, vous avez confondu deux dates (vous pensiez que l'examen était programmé demain or il s'est déroulé aujourd'hui). Vous aviez pourtant étudié votre cours et vous allez vous retrouver en 2ème session à cause d'une simple distraction. Cet échec ne rendra pas compte de vos réelles compétences : vous avez l'impression que votre bulletin ne dira pas la vérité à propos de qui vous êtes.

Comment vous comportez-vous ?

A. Vous profitez du fait que l'horaire des examens a été annoncé avec un peu de retard pour tenter d'introduire un recours contre la faculté. En effet, votre oncle est avocat, ce qui devrait faciliter la chose.
B. Vous demandez à l'ami de votre mère, qui est médecin, de vous faire un certificat de maladie afin de tenter de convaincre l'enseignant de reprogrammer ledit examen pour vous dans quelques jours.
C. Vous assumez votre oubli et réfléchissez aux stratégies à mettre en place afin d'éviter ce genre de situation à l'avenir.
D. Vous essayez de contacter le secrétaire de faculté qui est un ami de votre père, pour qu'il convainque le professeur de vous laisser expliquer les raisons de votre non-présentation de l'examen et de vous permettre de passer l'examen en oral.

Question 25. Les examens de juin à l'université ne peuvent pas s'organiser en présentiel en raison d'une nouvelle pandémie. Les épreuves certificatives écrites se déroulent en ligne sans aucun logiciel intrusif anti-triche. Les étudiant·e·s sont néanmoins tenus de signer sur l'honneur une charte de confiance par laquelle ils s'engagent à ne pas tricher et à répondre aux questions seul, sans l'aide d'un tiers ou d'une quelconque autre aide matérielle. G., étudiant en première année de physique, a signé cette charte. Il n'a pas eu beaucoup de temps pour étudier son cours. Il comptait sur la journée d'hier, mais il a regardé trop longtemps des matchs de Roland-Garros. Se trouvant en très mauvaise posture, il appelle son ami B. pour lui demander conseil quant à l'attitude à adopter.

Parmi les quatre possibilités ci-dessous, laquelle est une bonne réaction de B. ?

A. « Tu es dans le pétrin », conclut B. après avoir attentivement écouté G., « mais je ne sais pas trop comment t'aider ». Subitement, cependant, il se souvient d'une situation assez proche que son oncle, qui est avocat, avait évoquée devant lui. Une étudiante qui n'avait pas passé un examen sans raison valable avait présenté après coup un certificat médical de complaisance. L'université l'avait refusé, mais finalement, suite à l'intervention de l'avocat, la Faculté avait accepté qu'elle présente l'examen à l'oral, afin d'éviter des frais de procédure et un risque de publicité négative trop important.

B. B., scandalisé par l'inconséquence de G., ne peut se retenir de se mettre en colère ; assez vite, cependant il se ravise, s'excuse et dit à son ami « Désolé de m'être emporté, mais tu prends tant de risques ! Essayons de discuter sereinement pour voir comment éviter ton échec. »

C. B. est assez gêné de la situation. Il écoute silencieusement G., puis lui dit « OK tu as fait une bêtise, je ne vais pas te juger. Mais ne crois-tu pas que tu devrais essayer de voir la situation en adulte ? » puis, après un long silence il dit « Tiens, au fond, ils ont mis en place ce dispositif qui filme les étudiants avec la caméra de l'ordinateur ? » Il se tait à nouveau, puis dit simplement « Allez, salut, vieux » et raccroche.

D. B. dit à G. « Plusieurs possibilités te sont disponibles ; je pense que ce serait intéressant que tu les écrives sur une feuille de papier et que tu y réfléchisses attentivement. Demain, si tu veux, téléphone-moi entre 9h et 10h et on en parlera. Je suis ton ami, donc je te dirai honnêtement ce que je pense de ta réflexion. Mais je respecterai ta décision ».

Question 26. Une patiente de 60 ans est atteinte d'un cancer du sein. Celui-ci s'est généralisé, et des tumeurs osseuses sont apparues. Dans votre position de cancérologue-traitant·e, vous considérez que son espérance de vie est de quelques mois tout au plus.

Lors d'une consultation, la patiente vous informe que, à côté du traitement que vous lui avez prescrit, elle prend aussi quotidiennement une préparation à base de plantes qu'elle a achetée sur Internet (et qui n'est pas enregistrée comme médicament en Belgique).

Quelle est votre réaction ? Parmi les propositions suivantes, indiquez laquelle est la plus adéquate.

A. Après avoir examiné la composition de la préparation sur Internet, vous lui laissez prendre la préparation qui ne devrait pas être toxique et pourrait l'aider psychologiquement.

B. Après avoir longuement écouté la patiente, vous lui indiquez, le plus gentiment possible, que, dans ces conditions, vous ne pouvez plus rien faire pour elle.

C. Vous téléphonez pendant la consultation à une consœur pour qu'elle prenne la patiente en charge.

D. Vous indiquez à la patiente que l'ajout de ce produit aux médicaments prescrits n'est pas indiqué car aucune donnée scientifique rigoureuse ne justifie son usage.

Question 27. Un de vos condisciples de Master de sciences dentaires se vante auprès de vous de ne rien avoir étudié et d'avoir une méthode de triche quasi indétectable. Ses résultats sont, de fait, excellents puisqu'il termine sa session de janvier avec une moyenne de 17,3/20. Vous avez beaucoup travaillé et étudié pour réussir vos examens mais votre moyenne n'est que de 14/20.

Quelle est la meilleure attitude ?

A. Vous interrogez votre condisciple pour le questionner sur la portée de son système : « Est-ce que cela peut faire réussir des incapables ? ». « Non », dit-il, « ce n'est qu'un truc qui permet aux bons étudiants d'obtenir de meilleurs points encore pour qu'ils soient mieux identifiés par les profs ». Comme il n'y a pas vraiment là de véritable problème moral, vous décidez d'essayer au prochain examen. Vous réfléchirez ensuite à tête reposée pour décider de poursuivre ou non.

B. Vous interpellez votre condisciple et lui dites que son attitude n'est pas acceptable car ses futurs patients risquent de pâtir de sa fausse expertise.

C. A mots couverts, vous diffusez des messages sur les réseaux sociaux où vous laissez entendre que d'aucuns obtiennent des notes qui ne représentent pas leurs connaissances ; vous ne nommez pas le condisciple, mais vous donnez quelques détails qui lui feront comprendre que c'est bien de lui qu'on parle.

D. Vous rédigez un message anonyme adressé à tous les élèves et au doyen de la Faculté pour dénoncer les faits : il faut que les responsables de l'évaluation soient mis au courant pour qu'ils sécurisent mieux leurs procédures d'examen.

Question 28. Un enseignant (Monsieur A.) découvre un jour qu'un de ses collègues (Monsieur T.) donne manifestement cours sous l'influence de l'alcool. C'est d'autant plus dangereux que celui-ci donne un cours pratique de chimie et que son intoxication augmente le risque d'accident pour lui, voire pour ses élèves. Monsieur A. a déjà eu, d'ailleurs, l'impression, lors d'une fête de l'école, que Monsieur T. s'alcoolisait de manière excessive.

Comment Monsieur A. pourrait-il réagir à cette situation ? Quelle est la meilleure des 4 propositions ci-dessous ?

A. Monsieur A. doit rapidement solliciter un entretien avec le directeur de l'école pour l'informer de sa constatation, car l'école ne peut pas accepter une telle attitude.

B. Quelles que soient ses bonnes intentions, Monsieur A. se doit de respecter les choix et la vie privée de son collègue. Il doit donc réfréner son élan naturel et garder le silence sur cette situation.

C. Monsieur A. ne peut tolérer cette situation dangereuse ; cependant, pour éviter des problèmes à son collègue, il va discrètement avertir quelques élèves de confiance.

D. Monsieur A. doit interpeller son collègue concernant les risques de sa consommation et, si celui-ci ne réagit pas après plusieurs mises en garde, informer les autorités compétentes.

Question 29. Un·e de vos ami·e·s, du même genre que vous, vous confie penser à changer de genre.

Parmi les réponses envisageables, listées ci-dessous, laquelle est la plus adéquate ?

A. « Je pense que je ne suis pas la bonne personne pour te conseiller. Pour ce genre de chose, tu devrais consulter un médecin spécialisé ; je crois qu'il y a un psychiatre très bien au centre St F., dans la rue où est la bibliothèque de psycho ».

B. « Je sais que tu es mal dans ta peau ; très mal, si tu songes à des changements si radicaux. Mais je crois qu'avant d'en arriver là, tu devrais essayer de résoudre tes problèmes psychologiques en respectant ta nature ».

C. « C'est une décision très importante. Il te faut y penser sereinement pour savoir si tu te sentirais vraiment mieux après ce changement. Si tu le souhaites, je peux t'aider à y réfléchir ».

D. « C'est une bonne nouvelle, ça. Enfin, tu vas respecter ta personnalité vraie. Je suis 100% avec toi. C'est sûr que tu vas vraiment aller beaucoup mieux. Et peut-être que la nature de nos relations pourrait évoluer, non ? ».

Question 30. Les représentations sociales liées aux genres féminin et masculin influencent le rapport au corps, la perception des symptômes, le recours aux soins des malades, mais aussi l'interprétation des signes cliniques et la prise en charge des pathologies par les professionnels de santé. On appelle en général cela « biais de genre ». Dans le domaine de la santé, le biais de genre est spécialement dangereux, car il peut conduire à des analyses et/ou à des décisions non fondées sur des évidences scientifiques et, par voie de conséquence, potentiellement nocives pour les patient·e·s.

Vous êtes diplômé·e en médecine générale, vous avez acquis beaucoup d'expérience sur le terrain et vous vous sentez maintenant en confiance. Récemment, vous avez obtenu l'autorisation qui vous permet d'accueillir des jeunes en formation dans le cadre d'un stage. L'un·e d'entre eux semble très inquiet·ète à propos du biais de genre, qui l'insécurise fortement. Parmi les 4 conseils ci-dessous qui pourraient lui être donnés, lequel est le plus adéquat ?

A. « Le maître mot, c'est « connais-toi toi-même », comme l'a fait dire Platon à Socrate. Tous les humains peuvent avoir des perceptions parfois distordues ou influencées erronément par leur genre propre, par des faits ou des évènements extérieurs, parfois à des croyances ou convictions personnelles. Le médecin doit travailler sur lui-même et s'en libérer ; cela fait partie de son engagement, et c'est ce qui fait de lui un sage dans une société de plus en plus fébrile ».

B. « Il faut avant tout rester serein, et surtout ne pas paniquer : les différences sexuelles sont une réalité concrète décrite depuis fort longtemps, et qui existe même hors de l'espèce humaine. Cela, ça ne doit plus être prouvé, depuis le temps… ! On vous l'a appris à l'Université, j'espère. Il suffit de réfléchir sereinement, sans préjugés et en dehors de toute mode ou courant de pensée ».

C. « On ne vous l'a peut-être pas dit à l'Université, mais il est indispensable de maîtriser dans le détail les données épidémiologiques concernant les maladies répertoriées par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). C'est le truc infaillible ! ».

D. « Votre responsabilité première, c'est d'adopter systématiquement une approche globale et ouverte en écoutant activement les plaintes des patient·e·s, en scrutant les signes cliniques et en tentant d'explorer les diverses hypothèses explicatives ».